IMSS

Dirección de Prestaciones Médicas

Coordinación de Proyectos Especiales en salud

Guía para la elaboración del Plan de Continuidad de Operaciones de los Establecimientos de Salud

Índice

Índice 1
Directorio 2
1. Objetivo, alcance y definiciones 4
2. Principios generales para elaborar el plan 5
3. Proceso de planificación para elaborar el Plan de Continuidad de Operaciones. 6
Paso 1. Asignación de responsables y recursos 6
Paso 2. Ejecutar una evaluación de riesgos 6
Paso 3. Realizar un análisis de impacto para la continuidad operativa 8
Paso 4. Definir la línea de sucesión y delegación de autoridad 9
Paso 5. Definición de acciones de mitigación y recuperación 9
Paso 6. Gestión de registros y sistemas vitales 10
Paso 7. Estrategia de recuperación temprana 10
Paso 8. Puesta prueba y mejora continua 11
4. Anexos 13
Anexo 1. Diagrama de flujo 13
Anexo 2. Identificación de procesos críticos para cada servicio del hospital 14
Anexo 3. Evaluación de Riesgos 16
Referencias 20
Recursos 21
Contacto 22

Directorio

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto
Dirección General

Dr. Jorge Gaviño Ambriz
Secretaría General

Dra. Alva Alejandra Santos Carrillo
Dirección de Prestaciones Médicas

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Mtro. Borsalino González Andrade
Dirección de Administración

Lic. Luisa Obrador Garrido Cuesta
Dirección de Incorporación y Recaudación

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Dirección Jurídica

Mtra. Claudia Laura Vázquez Espinoza
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo
Dirección de Finanzas

Lic. Javier Guerrero García
Dirección de Operación y Evaluación

Mtro. Arturo De Lucio Ortega
Dirección de Planeación para la Transformación Institucional

Dra. Janett Alvarado González
Coordinación de Proyectos Especiales en Salud

Este documento fue elaborado por la **Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS** e incorpora recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y mejores prácticas basadas en la evidencia sobre gestión de emergencias en salud y continuidad de operaciones en establecimientos de salud.

Este documento está alineado con los principios del Programa Hospital Seguro y atiende los criterios establecidos en los ítems 124, 128, 138 y 139.

Es responsabilidad de cada establecimiento de salud adaptar las recomendaciones aquí vertidas, considerando sus capacidades, recursos, nivel de atención, análisis de riesgos y condiciones particulares, bajo el criterio técnico y profesional del personal responsable, priorizando la seguridad de pacientes, personal y la continuidad de procesos y servicios.

Derechos reservados © 2026
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos patrimoniales.

1. Objetivo, alcance y definiciones

Objetivo:

Establecer los lineamientos para que los establecimientos de salud del IMSS, en todos los niveles de atención, identifiquen los servicios y procesos esenciales de la unidad y aseguren la continuidad de las funciones críticas antes, durante y después de un evento perturbador, mediante la implementación de acciones de recuperación que permitan minimizar los daños y reducir los tiempos de restauración.

Objetivos específicos:

- Facilitar la continuidad de los procesos y servicios críticos para la prestación de servicios médicos antes, durante y después de un evento perturbador que provoque alteración en su funcionamiento o infraestructura.

- Reducir las consecuencias físicas, psicológicas y psicosociales en pacientes y el personal de salud, debido al mal funcionamiento o detención de procesos y servicios críticos mediante protocolos sistematizados que aseguran atención prioritaria y la continuidad de la atención integral.

Ámbito de aplicación:

Aplica a todos los establecimientos de salud de primero, segundo, tercer nivel y sus servicios críticos (urgencias, hospitalización, terapia intensiva, tococirugía, quirófanos, laboratorio, entre otros).

Definiciones clave:

- **Continuidad de Operaciones:** Capacidad estratégica de un hospital para mantener la prestación ininterrumpida de servicios esenciales de salud, como urgencias, cuidados intensivos y quirófanos, ante interrupciones por emergencias en salud y desastres o fallas críticas.

- **Procesos críticos:** Un proceso crítico es toda aquella actividad prioritaria que no puede ser suspendida aún en situaciones de emergencias o desastres, ya que de suspenderse puede afectar gravemente la actividad primaria o sustantiva de la organización.

- **Gobernanza:** Conjunto de estructuras organizacionales, políticas, marcos normativos e institucionales, que facilitan la elaboración y puesta en práctica del Plan de Continuidad de Operaciones dentro del establecimiento de salud.

- **Objetivo de tiempo de recuperación (OTR):** la cantidad máxima de tiempo de inactividad que se permite para un proceso crítico antes de que el impacto se vuelva lo suficientemente grave como para obstaculizar drásticamente la seguridad del paciente y / o detener la continuación de los servicios.

- **Plan de contingencia:** Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a las operaciones del establecimiento de salud.

2. Principios generales para elaborar el plan

- **Identificación de procesos críticos.** El proceso sistemático mediante el cual se reconoce analiza y prioriza aquellas actividades, incluidas las que involucran actividades psicosociales, esenciales, indispensables para garantizar la continuidad de la atención médica, la seguridad del paciente y el funcionamiento operativo del establecimiento de salud, cuya interrupción total o parcial tendría un impacto significativo en la salud de la población, el personal, la infraestructura o los servicios.

- **Análisis y evaluación de riesgos.** El análisis incluye la identificación de amenazas para las funciones que se ejecutan en el establecimiento, así como la medición de la probabilidad de que ocurra un evento que amenace la interrupción de los procesos críticos de los servicios.

- **Análisis del Impacto.** Proceso sistemático mediante el cual se identifican, evalúan y valoran los riesgos que pueden afectar a los procesos críticos de un establecimiento de salud, con el fin de determinar las posibles consecuencias operativas, clínicas, administrativas y de seguridad que su materialización tendría sobre la continuidad de los servicios, la seguridad del paciente, la integridad del personal y la infraestructura, permitiendo establecer prioridades y definir medidas de prevención, mitigación y respuesta. Se enfoca en los efectos de la interrupción, permitiendo priorizar procesos críticos y definir estrategias de continuidad, mitigación y recuperación.

- **Estrategia de Mitigación.** Cómo resultado de la evaluación de riesgos se debe generar una lista de acciones de mitigación. Las estrategias de mitigación ayudan a los establecimientos de salud a disminuir y/o prepararse para el impacto en sus operaciones como consecuencia de un evento disruptivo.

- **Estrategia de recuperación.** Las acciones necesarias para ayudar al establecimiento de salud a recuperarse de un evento disruptivo y volver a las operaciones normales, conforman la estrategia de recuperación, la cual debe estar guiada por los objetivos de recuperación.

- **Aprendizaje y mejora continua.** Implica realizar entrenamientos periódicos, llevar a cabo simulacros (incluidos ejercicios de escritorio, funcionales y de despliegue) y actualizar los procedimientos después de cada evento real o práctica, con el fin de fortalecer de manera continua la capacidad de respuesta.

3. Proceso de planificación para elaborar el Plan de Continuidad de Operaciones.

Cada establecimiento de salud debe elaborar un plan de continuidad de operaciones que se utilizará cuando se produzca una interrupción de los servicios durante y después de un evento disruptivo, para ello es necesario que todos los integrantes del cuerpo de gobierno comprendan los pasos de la planificación de la continuidad de las operaciones, adopten la terminología utilizada, e identifiquen las diferencias entre las acciones de respuesta, las acciones de mitigación y las de recuperación.

Paso 1. Asignación de responsables y recursos

En este paso se asigna al personal capacitado y recursos necesarios para elaborar o actualizar el Plan de Continuidad de Operaciones. Al constituir el equipo de continuidad de operaciones, es importante facilitar que puedan trabajar y recopilar información de todas las áreas y servicios dentro del establecimiento de salud. El equipo trabajará con cada departamento, área o servicio para identificar los procesos que necesitan para poder funcionar, y luego priorizar cuáles son críticos. En este equipo deben incluirse a jefes de áreas críticas (clínica, tecnologías de la información (TI), administración, conservación, y si es posible, del área legal). Este equipo liderará el proceso y creará listas de verificación para sus funciones esenciales.

Paso 2. Ejecutar una evaluación de riesgos

Se debe realizar un **análisis de vulnerabilidad a riesgos** para identificar amenazas potenciales y vulnerabilidades, tales como desastres de origen en la naturaleza o antrópicos, ataques cibernéticos (especialmente ransomware), fallas de servicios públicos o pandemias. El objetivo es analizar la probabilidad y el impacto de cada amenaza y vulnerabilidad en las funciones críticas del hospital.

En este punto pueden tomarse como insumos las evaluaciones del programa Hospital Seguro, las realizadas por terceros acreditados y las instituciones especializadas en evaluación de riesgos, entre otros.

Evaluar los riesgos para el establecimiento de salud de forma periódica es un proceso formal que permite guiar las acciones de planificación y proporcionar evidencia a las estrategias y políticas para una mejor prevención, preparación, respuesta y recuperación; también garantiza la detección y las acciones tempranas de mitigación, lo que favorece que los establecimientos de salud y otras partes interesadas estén operativamente listas para una respuesta oportuna y eficaz.

Además de las amenazas de origen externo, existen las que se originan al interior de los establecimientos de salud, limitando o interrumpiendo la continuidad de sus operaciones, reduciendo la oferta de servicios, o generando la necesidad de traslado de pacientes a otras instalaciones.

Determinar los riesgos que pueden impactar en los procesos y servicios críticos, mediante la identificación de amenazas y vulnerabilidades, y su caracterización, la evaluación del nivel de riesgo en comparación con estándares predeterminados, objetivos, consecuencias directas o indirectas u otros criterios, es un insumo clave para la elaboración del Plan de Continuidad de Operaciones. Cuanto más alto sea el nivel de riesgo, más enfocado estará el esfuerzo en acciones para mitigarlo (anexo 3).

La evaluación se puede realizar tomando en cuenta los siguientes cuestionamientos:

- ¿Cuáles son las amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesto el establecimiento?
- ¿Qué amenazas tienen más probabilidades de manifestarse y afectar al establecimiento?
- ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades del establecimiento que podrían incrementar el impacto de una amenaza o afectar su capacidad de respuesta?
- ¿Cuál sería el impacto esperado que tendría cada amenaza?
- ¿Qué efecto tendrán nuestras medidas de mitigación actuales frente a cada riesgo identificado?

La evaluación periódica de riesgos en el establecimiento de salud favorecerá la programación de acciones para prevenir, prepararse y reducir los riesgos asociados de una amenaza hacia un proceso crítico. Los establecimientos de salud pueden utilizar datos históricos locales y

regionales de la gestión de emergencias, datos meteorológicos, atlas de riesgos y otras fuentes.

Los resultados de la evaluación deberán documentarse, validarse por el cuerpo de gobierno del establecimiento y utilizarse como insumo para la actualización del Plan de Continuidad de Operaciones.

Paso 3. Realizar un análisis de impacto para la continuidad operativa

Este análisis permite:

Identificar procesos y servicios críticos: Tanto clínicos (diagnósticos, terapéuticos, acceso a registros electrónicos, entre otras), psicosociales y de salud mental (atención psicológica en crisis, contención emocional, intervención en conducta suicida) como operativos (gestión administrativa y financiera, gestión de recursos humanos, abastecimiento, gestión de documentos como archivo clínico, entro otras).

Determinar tiempos máximos de inactividad: Establecer cuánto tiempo puede estar suspendida una función antes de que la atención al paciente se vea gravemente afectada.

Identificar recursos necesarios: Personal, equipo, suministros y sistema de tecnologías de la información requeridos para cada función.

En este paso se identifican y priorizan los procesos y servicios críticos, así como las amenazas probables para cada uno, mediante un enfoque multiamenaza, investigado a fondo para garantizar que se desarrollen capacidades que permitan mantener las funciones críticas, durante y después de un evento que las interrumpa (anexo 2).

Los procesos y servicios deben separarse por su relevancia en críticos y no críticos para cada departamento o servicio:

1) Los procesos y servicios críticos son funciones esenciales importantes para la misión de la organización y deben mantenerse durante un evento perturbador. Un ejemplo de un proceso crítico es el proceso quirúrgico y ejemplos de servicios críticos son los quirófanos y el servicio de urgencias.

2) Los procesos no críticos desempeñan una función importante para la organización, pero no esencial, durante un evento perturbador, para mantener la operatividad del establecimiento de salud. Un ejemplo de un proceso no crítico es la consulta externa.

La identificación de procesos y servicios críticos se realiza principalmente mediante el Análisis de Impacto en la continuidad de operaciones, de las interrupciones potenciales en funciones esenciales para priorizar su continuidad. Se debe considerar impactos en pacientes, operaciones y red integrada de servicios de salud. La clasificación de los procesos y servicios como críticos o no críticos puede variar en función del tipo de amenaza, la magnitud del evento disruptivo, el tiempo de interrupción y las capacidades disponibles del establecimiento de salud.

Paso 4. Definir la línea de sucesión y delegación de autoridad

Orden de Sucesión: Identificar quién asumirá el mando si los responsables principales no están disponibles; se recomienda una profundidad de 3 a 4 niveles jerárquicos.

Delegaciones de Autoridad: Identificar por escrito quién tiene el derecho legal de actuar en nombre de la dirección del hospital para asegurar la toma de decisiones rápida.

Paso 5. Definición de acciones de mitigación y recuperación

Definir las acciones de mitigación y recuperación para asegurar que los "procesos críticos" se puedan mantener durante y después de un evento, bajo las circunstancias y límites establecidos por la dirección del establecimiento, utilizando los peores escenarios posibles en esta planificación, las principales son:

Instalaciones de continuidad: Designar sitios alternos donde el establecimiento de salud pueda llevar a cabo sus funciones esenciales si el edificio principal queda inhabitable.

Comunicaciones interoperables: Establecer sistemas redundantes (teléfonos satelitales, radios de dos vías, alertas de texto) que no dependan de una sola red.

El cuerpo de gobierno del establecimiento de salud debe considerar la creación de estrategias y procedimientos de mitigación, protección y respaldos, tales como:

- Estructura interna y externa reforzada en el sitio físico.
- Asegurar que los sistemas de detección y extinción de incendios sean actuales y operables.
- Desarrollar soporte redundante de terceros (proveedores alternos de insumos y recursos, combustibles, agua potable, gases medicinales, telecomunicaciones, entre otros).

- Desarrollar sistemas de respaldo fuera del sitio para datos, software crítico e instalaciones.
- Procedimientos para incorporar un inventario apropiado de equipos críticos.
- Desarrollar alternativas en caso de interrupción para: energía o comunicaciones o datos y registros, y recuperación de información o Instalación o dotación de personal.

Paso 6. Gestión de registros y sistemas vitales

Es necesario catalogar y proteger:

Registros Vitales: Documentación crítica como expediente clínico de pacientes, información de auxiliares diagnósticos, nóminas y bases de datos de personal, entre otros.

Sistemas y equipos vitales: Computadoras, equipos médicos y sistemas de comunicación indispensables para las operaciones. Se deben implementar soluciones robustas de respaldo de datos y recuperación de desastres para garantizar la integridad de la información conforme al marco normativo nacional.

Paso 7. Estrategia de recuperación temprana

Durante la fase de recuperación se deberán reorganizar y apoyar al personal para mantener la operación, a través de acciones como:

- Asignar roles de recuperación y extensión de horarios según prioridad de servicios.
- Asegurar bienestar físico y psicológico del personal afectado por el evento disruptivo, mediante intervenciones planificadas de apoyo psicosocial, contención emocional y referencia oportuna a servicios de salud mental.
- Capacitar en procedimientos temporales de atención y uso de equipos alternativos.

Las acciones de recuperación se deben contemplar desde el punto de vista del tiempo de aplicación lo cual es solo enunciativo sin ser estricto en su aplicación:

- Corto plazo (días): restablecer servicios no críticos, atención temporal y evaluar vulnerabilidades.
- Mediano plazo (semanas–meses): reparar infraestructura, mantener atención continua y adaptar operaciones.

- Largo plazo (meses–años): reconstrucción, mitigación de riesgos futuros y desarrollo de resiliencia institucional.

Además, el plan debe considerar:

Devolución: Planificar cómo transferir la autoridad y las funciones a otra organización en caso de un evento catastrófico que destruya las instalaciones o afecte a la mayor parte del personal.

Reconstitución: Establecer el proceso para reanudar las operaciones normales en la instalación original o en una nueva una vez concluida la emergencia.

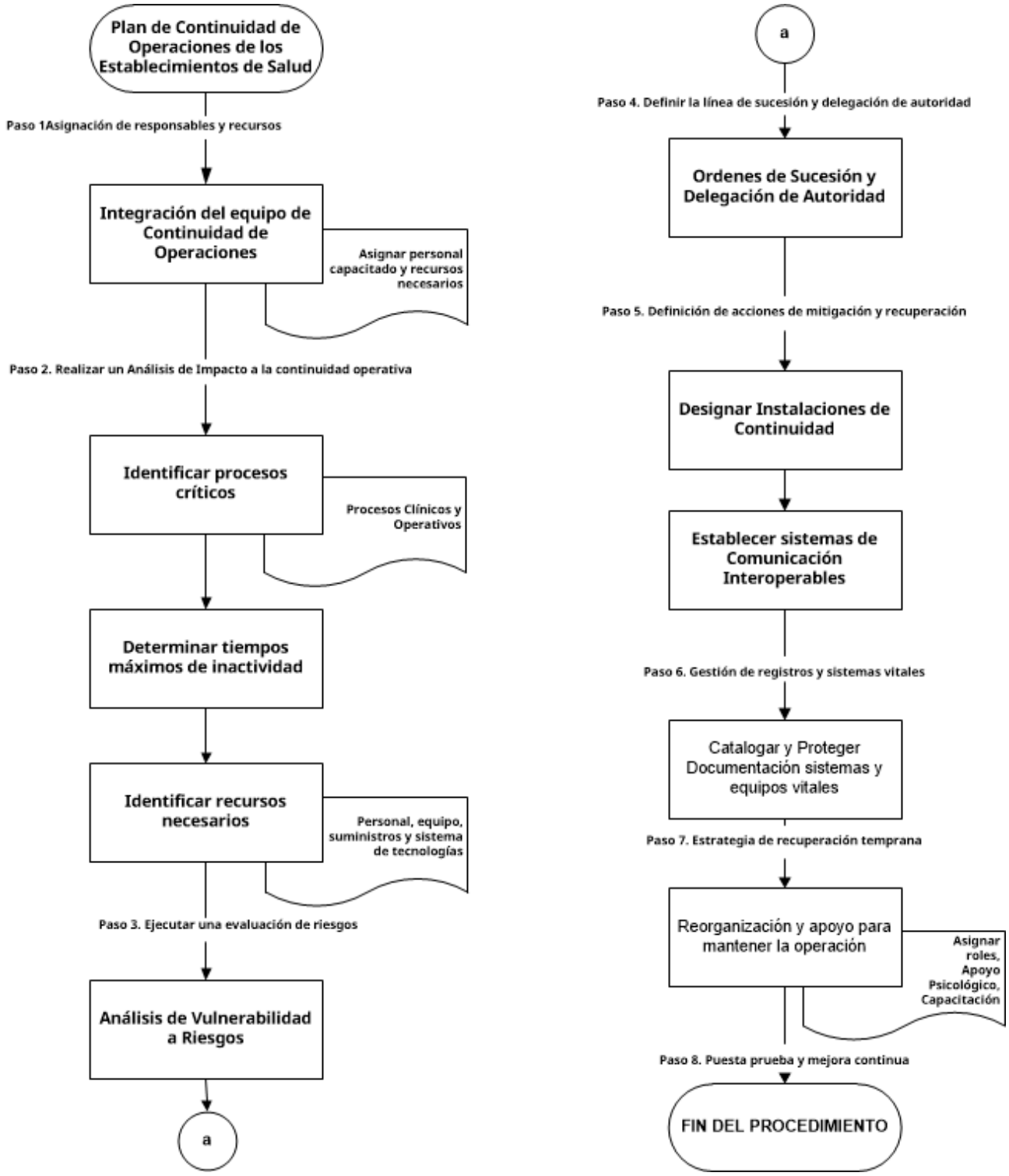
Paso 8. Puesta prueba y mejora continua

Puesta a prueba y desarrollo del plan de mantenimiento del plan de continuidad de operaciones. Una vez elaborado el plan, se debe probar mediante ejercicios de simulación y simulacros, incorporando en el documento los aspectos de mejora identificados. Parte del Plan de Continuidad de Operaciones debe especificar cómo se capacitará al personal, incluida la frecuencia de la capacitación, quién es responsable de supervisar la capacitación y qué personal recibirá capacitación sobre temas específicos.

Al final del proceso debe quedar establecido por escrito quienes serán los responsables de revisar y actualizar el plan, la periodicidad con la que esto se debe hacer (se recomienda hacerlo por lo menos 1 vez al año), y asociado a la rotación del personal, el programa de capacitación continua, pero sobre todo posterior a un evento real.

4. Anexos

Anexo 1. Diagrama de flujo



Anexo 2. Identificación de procesos críticos para cada servicio del hospital

Servicio de urgencias		
Proceso critico o función	Objetivo de Tiempo de recuperación (RTO)	Prioridad
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos		
Proceso critico o función	Objetivo de Tiempo de recuperación (RTO)	Prioridad
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Casa de máquinas		
Proceso critico o función	Objetivo de Tiempo de recuperación (RTO)	Prioridad
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Instructivo de llenado

1. Identificación del servicio
Complete cada bloque del anexo conforme al servicio específico (ej. Urgencias, UCI Adultos, casa de máquinas). Use este modelo para crear los espacios de acuerdo con los procesos y servicios críticos del establecimiento de salud.

El llenado deberá realizarse con la participación del responsable del servicio y personal clave.

2. Proceso crítico o función
Registre únicamente procesos esenciales, no actividades rutinarias.
Un proceso crítico es aquel que, al interrumpirse, genera impacto inmediato o severo en la operación del hospital.

Describa el proceso de forma concreta y operativa (ej. “Atención inicial y estabilización de pacientes críticos”, “Suministro continuo de oxígeno medicinal”).

3. Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO)
Indique el tiempo máximo aceptable en el que el proceso debe restablecerse tras una interrupción. El RTO deberá expresarse en minutos u horas, según corresponda.

Considere el impacto clínico, operativo y legal de la interrupción para definir el RTO.

4. Prioridad
Asigne la prioridad del proceso conforme a su criticidad:

- Alta: Interrupción compromete de forma inmediata la vida, la seguridad del paciente o la operación crítica.
- Media: Interrupción afecta la operación, pero puede sostenerse temporalmente con medidas alternas.
- Baja: Interrupción tolerable por un periodo limitado sin afectar funciones esenciales.

La prioridad debe ser congruente con el RTO asignado.

Anexo 3. Evaluación de Riesgos

Evaluación de riesgos				
1. Identificación de Amenazas	2. Caracterización (Nivel de riesgo)	3. Funciones o servicios que se verán afectados	4. Proceso donde se ejecutan las funciones	5. Departamento o servicio que ejecuta el proceso

Instructivo de llenado

1. Identificación de amenazas

Registre cada amenaza de manera clara y específica. Evite términos genéricos; describa el evento que podría ocurrir (ej. “Falla prolongada del suministro eléctrico”, “Sismo fuerte”, “Interrupción en el suministro de oxígeno medicinal”).

Cada fila debe corresponder a una amenaza.

2. Caracterización (nivel de riesgo)

La evaluación del riesgo se basa en la combinación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto esperado: Riesgo = Probabilidad x Impacto

Metodología para obtener el **nivel de riesgo**:

1. Evalúe probabilidad.
2. Evalúe impacto.
3. Determine el nivel de riesgo final usando la matriz.
4. Registre únicamente el nivel de riesgo final (Alto, Medio o Bajo) en la columna Caracterización (Nivel de riesgo).

La evaluación debe realizarse de forma colegiada, con participación de responsables técnicos y directivos.

1. Escala de **probabilidad** de ocurrencia	
Nivel	Descripción operativa
Alta	La amenaza es recurrente, ya ocurrió recientemente o existen condiciones claras para que se presente en el corto plazo.
Media	La amenaza es posible, ha ocurrido ocasionalmente o existen antecedentes en la región o institución.
Baja	La amenaza es poco probable, no existen antecedentes recientes o requiere condiciones excepcionales para ocurrir.

2. Escala de **impacto** en la continuidad operativa	
Nivel	Descripción operativa
Alto	Interrupción grave o total de servicios críticos, riesgo inmediato para la vida del paciente, daño institucional significativo o incumplimiento normativo.
Medio	Afectación parcial de servicios, retrasos importantes en la atención o necesidad de activar medidas alternas.

Bajo	Impacto limitado, manejable con recursos habituales, sin comprometer funciones críticas.

El **nivel de riesgo** que se registrará en el Anexo 3 se obtiene combinando la probabilidad y el impacto conforme a la siguiente matriz:

3. Determinación del **nivel de riesgo**			
Probabilidad	Impacto		
	Bajo	Medio	Alto
Alta	Medio	Alto	Alto
Media	Bajo	Medio	Alto
Baja	Bajo	Bajo	Medio

Interpretación operativa del nivel de riesgo:

4. Clasificación final del **riesgo**	
Nivel de riesgo	Interpretación operativa
Alto	Riesgo crítico que requiere acciones inmediatas de mitigación y planes específicos de continuidad.
Medio	Riesgo relevante que debe ser controlado mediante medidas preventivas y de preparación.
Bajo	Riesgo aceptable que se monitorea y gestiona con controles existentes.

3. Funciones o servicios que se verán afectados

Indique las funciones, servicios o actividades críticas que podrían verse impactadas por la amenaza. Priorice funciones esenciales para la atención médica y la operación hospitalaria.

Puede incluir más de una función si corresponde.

4. Proceso donde se ejecutan las funciones

Especifique el proceso operativo o asistencial en el que se desarrollan las funciones afectadas.

El proceso debe corresponder a los identificados como críticos en el Anexo 2. Redacte el proceso de forma concreta y funcional.

5. Departamento o servicio que ejecuta el proceso

Indique el área responsable de ejecutar el proceso (ej. Urgencias, UCI, Ingeniería Biomédica, Mantenimiento, Farmacia).

Use la denominación oficial del servicio dentro del hospital.

Referencias

1. FEMA. Business Process Analysis and Business Impact Analysis User Guide. 2019 En: Continuity Resources and Technical Assistance. Disponible en: https://www.fema.gov/emergency-managers/national-preparedness/continuity
2. Hick J, Einav S, Hanfling D, Kissoon N. Surge Capacity Principles Care of the Critically Ill and Injured During Pandemics and Disasters: CHEST Consensus Statement. CHEST 2014; 146 (4_Suppl): e1S - e16S
3. Klein MG, Chen G CJ, Lii E; Mao K, Mesbahi H, Zhue T, Muckstadt, JA, Hupper N. COVID 19 Models for Hospital Surge Capacity Planning: A Systematic Review Disaster Medicine and Public Health Preparedness Cambridge University Press. 2020
4. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Sendai, Japón. 2015. https://www.undrr.org/es/implementando-el-marco-de-sendai/que-es-el-marco-de-sendai-para-la-reduccion-del-riesgo-de
5. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). PHE-EMO/HIM. Exposición de los hospitales a las amenazas de origen natural en las Américas. Disponible en: https://sedac.ciesin.columbia.edu/
6. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Marco de respuesta multiamenaza para el Sector de la Salud. Modelo operativo para la implementación de las funciones para la respuesta ante emergencias en salud y desastres. Washington D.C. 2019.
7. Registro de desastres en la región de las Américas de 01 de enero de 2020 al 11 de marzo de 2022. EM-DAT. CRED. UC Louvain, Brussels, Belgium. Consultado: mar. 11, 2022. Disponible en : www.emdat.be
8. The Business Continuity Institute. Good Practice Guidelines. United Kingdom. 2018. En: http://biblioteca.bcrp.gob.pe/absysNet/WebOpac/Model01/Multimedia02/1234124.pdf
9. United States Department of Homeland Security. "Business Continuity Plan". Recuperado 16 de Julio 2022. Disponible en: https://www.ready.gov/business-continuity-plan

Recursos

Curso: Sistema de Comando de Incidentes para Hospitales (SCI-H). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/sistema-de-comando-de-incidentes-para-establecimientos de salud.

Curso: Marco de respuesta multiamenaza: Planeamiento hospitalario para la respuesta a emergencias en salud y desastres. Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/respuesta-multiamenaza-planeamiento-hospitalario-emergencias

Curso: Curso virtual de evaluación de establecimientos de salud a través del índice de seguridad hospitalaria (ISHv2). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/evaluacion-de-establecimientos-de-salud

Contacto

Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED)

(24/7 los 365 días del año)

Teléfonos:

55 52 62 53 68 (directo)

55 52 38 27 00 (conmutador), Extensiones: 19081, 19083, 10315, 19832 y 19831

55 80 03 58 24 (WhatsApp)

Sitio web: https://cvoed.imss.gob.mx

Correo electrónico: cvoed.coord@imss.gob.mx